

SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SOBRAL

PROTOCOLO DE TROMBOPROFILAXIA

Escore de Padua • HAS-BLED • TVP/TEP • FA • Anticoagulação

Baseado em: ASH VTE Guidelines 2018 • ACCP Antithrombotic Therapy 2021 • ESC FA Guidelines 2020 • ISTH Guidelines 2022

1. ESCORE DE PADUA — RISCO DE TVP EM PACIENTES CLÍNICOS

Fator de Risco	Pontos
Câncer ativo (metástase / quimio/radio nos últimos 6 meses)	3
TVP/TEP prévio (exceto trombose superficial)	3
Imobilidade ≥ 3 dias (repouso no leito ou mobilidade muito reduzida)	3
Trombofilia conhecida (defic. proteína C ou S, anticoagulante lúpico, SAAF, JAK2, FV Leiden, protrombina G20210A)	3
Trauma e/ou cirurgia recente (≤ 1 mês)	2
Idade ≥ 70 anos	1
Insuficiência cardíaca e/ou insuficiência respiratória	1
IAM ou AVC isquêmico agudo	1
Infecção aguda e/ou doença reumatológica	1
Obesidade (IMC ≥ 30)	1
Tratamento hormonal em curso (ACO, TRH)	1

Pontuação	Risco	Conduta
< 4	BAIXO RISCO	Deambulação precoce + meias de compressão. SEM heparina farmacológica de rotina
≥ 4	ALTO RISCO	Heparina farmacológica (ver abaixo) + meias de compressão elástica. Reavaliar diariamente

2. ESCOLHA DO ANTICOAGULANTE PROFILÁTICO

Situação	Droga de Escolha	Dose	Observações
Paciente clínico geral (Padua ≥ 4)	Enoxaparina (HBPM)	40 mg SC 1x/dia	Aplicar 24h após admissão. Manter durante internação e até deambulação plena

Situação	Droga de Escolha	Dose	Observações
Função renal reduzida (ClCr 15–30 mL/min)	HNF (Heparina não fracionada)	5.000 UI SC 8/8h	HBPM contraindicada se ClCr < 15. Monitorar anti-Xa em casos especiais
Função renal grave (ClCr < 15 ou diálise)	HNF	5.000 UI SC 8/8h	Evitar HBPM. Considerar compressão mecânica associada
Obesidade severa (> 100 kg)	Enoxaparina	40 mg SC 12/12h ou 0,5 mg/kg/dia	Dose padrão pode ser insuficiente. Avaliar nível anti-Xa se disponível
Gravidez	Enoxaparina	40 mg SC 1x/dia (ajustar conforme peso)	HBPM é a 1ª escolha na gestação. Warfarina e DOACs contraindicados
Plaquetopenia ≥ 50.000	Enoxaparina (com cautela)	20 mg SC 1x/dia	Abaixo de 50.000: risco hemorrágico > benefício → compressão mecânica

■ **TROMBOCITOPENIA INDUZIDA POR HEPARINA (TIH):** Plaquetas caem ≥ 50% após 5–10 dias de heparina
→ **SUSPENDER** toda heparina e usar Fondaparinux ou Argatroban

3. ESCORE HAS-BLED — RISCO HEMORRÁGICO EM ANTICOAGULAÇÃO

■ Usar em pacientes candidatos a anticoagulação (especialmente em FA). NÃO é contraindicação à anticoagulação — é para identificar fatores modificáveis.

Letra	Fator	Pontos
H	Hipertensão não controlada (PAS > 160 mmHg)	1
A	Função renal anormal (creatinina > 2,26 ou diálise) e/ou função hepática anormal (cirrose ou bilirrubina 2x + TGO/TGP 3x)	1 (cada)
S	AVC prévio	1
B	Sangramento prévio ou predisposição (úlceras, plaquetas < 100.000, anemia)	1
L	INR lábil (< 60% do tempo na faixa terapêutica) — só para warfarina	1
E	Idoso (≥ 65 anos)	1
D	Drogas (AINEs, AAS, clopidogrel, álcool ≥ 8 doses/semana)	1 (cada)

Pontuação	Risco	Sangramento em 1 ano	Conduta
0–1	BAIXO	~1%	Anticoagular com segurança. Controle de fatores modificáveis
2	MODERADO	~2%	Anticoagular com monitoração rigorosa. Corrigir fatores modificáveis
≥ 3	ALTO	> 3,7%	ALTO RISCO NÃO CONTRAINDICA ANTICOAG se risco trombótico > hemorrágico. Corrigir fatores modificáveis: PAS, AINE, álcool

4. CHA₂DS₂-VASc — RISCO DE AVC EM FIBRILAÇÃO ATRIAL

Letra	Fator	Pontos
C	Insuficiência cardíaca congestiva ou FEVE < 40%	1
H	Hipertensão arterial	1
A■	Idade ≥ 75 anos	2
D	Diabetes mellitus	1
S■	AVC/AIT/tromboembolismo prévio	2
V	Doença vascular (IAM prévio, arteriopatia periférica, placa aórtica)	1
A	Idade 65–74 anos	1
Sc	Sexo feminino (fator modificador, não isolado)	1

Pontuação	Risco AVC/ano	Conduta (homens / mulheres)
0 (homem) / 1 (mulher)	Baixo (< 1%/ano)	Anticoagulação NÃO recomendada rotineiramente
1 (homem) / 2 (mulher)	Intermediário	Anticoagulação deve ser CONSIDERADA (risco/benefício individual)
≥ 2 (homem) / ≥ 3 (mulher)	Alto (> 2%/ano)	Anticoagulação RECOMENDADA salvo contraindicação absoluta

5. ANTICOAGULAÇÃO NA FA — ESCOLHA DO AGENTE

Agente	Dose Padrão (FA)	Indicação Preferencial	Contraindicações
Apixabana (Eliquis)	5 mg 12/12h (2,5 mg 12/12h se ≥2: >80a, <60kg, Cr>1,5)	1ª escolha: menor sangramento GI Idosos, FA não valvar	ClCr < 15; valvopatia mitral reumática; prótese valvar mecânica
Rivaroxabana (Xarelto)	20 mg 1x/dia com jantar	Adesão (1x/dia). FA não valvar	ClCr < 15; gravidez; valvopatia mitral reumática
Dabigatrana (Pradaxa)	150 mg 12/12h (110 mg se > 80 anos ou ↑risco sangramen.)	Menor risco de AVC vs warfarina	ClCr < 30; hepatopatia ativa; prótese valvar mecânica
Warfarina (Varfarina)	Dose ajustada para INR 2–3	Prótese valvar mecânica; valvopatia mitral reumática; ClCr < 15	Gravidez (1T e 3T); alto risco de queda sem compensação
Heparina (HNF EV)	Conforme PTT 60–100s	Hospitalar: FA com reversão prevista; instabilidade; procedimento iminente	Sangramento ativo; TIH

■ DOACs são CONTRAINDICADOS em: prótese valvar mecânica, estenose mitral reumática moderada/grave, gravidez. Usar warfarina nestes casos.

6. TRATAMENTO DE TVP / TEP — SUMÁRIO

Diagnóstico	Droga 1ª escolha	Dose	Duração mínima
TVP proximal ou TEP (1º evento, fator de risco removível)	Rivaroxabana ou Apixabana	Riva: 15mg 12/12h 21d → 20mg 1x/d Apixa: 10mg 12/12h 7d → 5mg 12/12h	3 meses
TVP/TEP recorrente ou idiopático	Anticoagulação estendida (DOAC ou Warfarina)	Mesmas doses de manutenção	≥ 6 meses; reavaliar indefinidamente
TVP/TEP com câncer ativo	Apixabana ou Rivaroxabana (ou Enoxaparina)	Mesmas doses acima Enox: 1 mg/kg 12/12h SC	≥ 6 meses; manter enquanto câncer ativo
TEP maciço com choque	Trombolítico (Alteplase) + Heparina após	Alteplase 100 mg EV em 2h HNF: bolus 60 UI/kg após	Avaliar cirurgia ou trombectomia se contraindicado

Referências: Konstantinides SV et al. 2019 ESC Guidelines on pulmonary embolism; Lip GYH et al. 2020 ESC AF Guidelines; Lim W et al. ASH VTE Guidelines 2021; ISTH Bleeding Risk Scores 2022.